



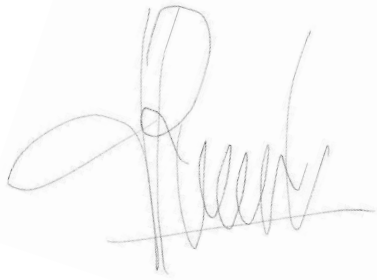
RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PENGORGANISASIAN
REKAM MEDIS**

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor : 069.2/I-PDM/DIR/I/2026

Tentang
Pedoman Pengorganisasian Rekam Medis

Disusun oleh :
Kepala Unit Rekam Medis



(**Annisa Aulia Savira, A.Md.Kes**)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(**Dr. dr. Aslichah. M. Kes. AFP**)

Ditetapkan oleh :
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(**dr. Resti Lestantini, M. Kes**)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pengorganisasian Rekam Medis dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pengorganisasian Rekam Medis ini, pelayananan unit rekam medis Rumah Sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 30 Januari 2026

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

TIM PENYUSUN

1. dr. Resti Lestantini, M. Kes
2. Dr. dr. Aslichah. M. Kes. AFP
3. Dwi Novianti, Amd. Ak, S. Kes
4. Annisa Aulia Savira, A.Md.Kes

DAFTAR ISI

SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
TIM PENYUSUN	iv
DAFTAR ISI	v
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	vii
LAMPIRAN	1
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud Dan Tujuan	1
BAB II	2
GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	2
2.1 Deskripsi Rumah Sakit Prima Husada	2
2.2 Sejarah Institusi Rumah Sakit Prima Husada	2
BAB III	4
VISI, MISI, MOTTO, NILAI BUDI UTAMA, TUJUAN	4
3.1 Visi	4
3.2 Misi	4
3.3 Motto	4
3.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama	4
3.5 Tujuan	4
BAB IV	5
STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT	5
4.1 Bagan Organisasi	5
4.2 Keterangan / Pengertian	6
BAB V	8
STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI REKAM MEDIS	8
5.1 Tanggung Jawab Instalasi Rekam Medis	9
5.2 Keanggotaan Instalasi Rekam Medis	9
BAB VI	10
URAIAN JABATAN	10
6.1 Uraian Tugas	10
6.2 Tanggung Jawab	14

6.3	Wewenang	15
6.4	Tugas Klinik	15
BAB VII		19
TATA HUBUNGAN KERJA		19
7.1	Skema Hubungan Kerja	19
7.2	Hubungan Eksternal	19
7.3	Hubungan Internal	19
BAB VIII		20
POLA KETENAGAAN		20
8.1	Pola Ketenagaan	20
8.2	Evaluasi dan Pemutakhiran Staf	22
BAB IX		23
KEGIATAN ORIENTASI		23
BAB X		25
PERTEMUAN/RAPAT		25
10.1	Rapat Rutin Bulanan	25
10.2	Rapat Insidentil	25
BAB XI		26
PELAPORAN		26

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 069.2/I-PDM/DIR/I/2026
TENTANG
PEDOMAN PENGORGANISASIAN REKAM MEDIS
DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada NOMOR 069.2/I-PDM/DIR/I/2026 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rekam Medis masih belum memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rekam Medis.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasyankes;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada 838.1/I-KEP/DIR/IX/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPMI-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PENGORGANISASIAN REKAM MEDIS.

Pasal 1

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rekam Medis digunakan sebagai acuan dalam Organisasi Instalasi Rekam Medis di Rumah Sakit Prima Husada.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 374.B/RSPH/I-PER/DIR/IX/2015 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rekam Medis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 30 Januari 2026

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA NOMOR 069.2/I-
PDM/DIR/I/2026
TENTANG PEDOMAN
PENGORGANISASIAN INSTALASI
REKAM MEDIS

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rekam medis berdasarkan sejarahnya selalu berkembang mengikuti kemajuan ilmu kesehatan dan kedokteran. Sejak masa pra kemerdekaan rumah sakit di Indonesia sudah melakukan pencatatan kegiatan medis, namun belum dilaksanakan dengan baik atau belum mengikuti penataan sistem informasi yang benar.

Rekam medis merupakan salah satu sumber data yang sangat vital dalam penyelenggaraan sistem informasi manajemen di rumah sakit dan sangat penting dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen.

1.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 034/Birhup/1972 ada kejelasan bagi rumah sakit mengenai kewajiban rumah sakit untuk menyelenggarakan rekam medis.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Agar penyelenggaraan rekam medis dapat dilaksanakan dengan baik maka harus dilengkapi dengan pedoman organisasi maupun pedoman pelayanan rekam medis tentang tata cara penyelenggaraan rekam medis yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh tenaga kesehatan baik medis, para medis maupun non medis yang bertugas di Rumah Sakit Prima Husada

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

2.1 Deskripsi Rumah Sakit Prima Husada

Rumah Sakit Prima Husada berlokasi di Banjararum Selatan No 3 – 7 Mondoroko, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang 65153, Jawa Timur, Indonesia. Telp. 0341 – 458679, 458916, Fax: 0341 – 441874, email : primahusadamalang@gmail.com, info@rs-primahusada.id, website : www.rs-primahusada.id.

Rumah Sakit Prima Husada adalah salah satu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan langsung khususnya pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur dan memiliki 3 Manajer yaitu Manajer Pelayanan dan Manajer Keuangan dan Akuntansi dan Manajer Umum dan di dalam tugasnya dibantu oleh Kepala Bidang dan Kepala Bagian.

Rumah Sakit Prima Husada dengan pelayanan meliputi pelayanan Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Kamar Operasi, Penunjang Medik, dan Penunjang Non Medik, serta Instalasi Rawat Inap yang terdiri dari kelas I, II, III, VIP dan VVIP.

Dalam upaya memberikan pelayanannya, rumah sakit dituntut memberikan pelayanan sebaik – baiknya sebagai *public service*. Meningkatnya tuntutan dapat dilihat dengan munculnya kritik – kritik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan yang diberikan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Rumah Sakit Prima Husada perlu menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan secara bertahap melalui upaya program peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

2.2 Sejarah Institusi Rumah Sakit Prima Husada

Berawal dari Praktek pribadi dr. Sadi Hariono, MMRS sebagai dokter umum sejak tahun 1990 di Banjararum Selatan No. 3B, kami telah mengabdikan diri melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Seiring dengan perkembangan penduduk dan peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih luas, maka kamipun berupaya mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, sehingga mengantarkan kami pada

berdirinya Rumah Sakit Prima Husada.

Perjalanan Peningkatan Status Pelayanan :

Tahun 1990 – 2005	:	Praktek Pribadi Dokter Umum
Tahun 2005 – 2009	:	Balai Pengobatan Prima Husada
Agustus 2009	:	Klinik Rawat Inap Layanan Medik Dasar
Mei 2010	:	Menjadi Rumah Sakit Umum dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
Tahun 2010 – 2014	:	Izin Operasional Rumah Sakit Sementara
Februari 2015	:	Izin Operasional Rumah Sakit Tetap
Februari 2016	:	Penetapan Rumah Sakit Tipe C
Maret 2016	:	Akreditasi Paripurna
Desember 2016	:	Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik se Malang Raya Tahun 2016
April 2017	:	Juara 1 Pelayanan dan Respon terbaik (Dinkes Kab. Malang)
Desember 2017	:	Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik se Jawa Timur Tahun 2017
Desember 2017	:	Pengembangan Gedung DPM
Februari 2018	:	Menjadi tempat dokter internsip

BAB III

VISI, MISI, MOTTO, NILAI BUDI UTAMA, TUJUAN

3.1 Visi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi :

“ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

3.2 Misi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat cepat dan akurat.
- b. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
- c. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

3.3 Motto

Sahabat Menuju Sehat

3.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

3.5 Tujuan

Rumah Sakit Prima Husada memiliki tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Prima Husada

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT

4.1 Bagan Organisasi



4.2 Keterangan / Pengertian

4.2.1 Unit Struktural

1) Direktur Rumah Sakit

Adalah kepala atau pejabat tertinggi di RS Prima Husada.

2) Kepala Bidang / Kepala Bagian

Adalah pejabat yang membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing-masing yaitu :

- a. Kepala Bidang Pelayanan Medik membantu Direktur dalam bidang Pelayanan Rumah Sakit.
- b. Kepala Bidang Penunjang Medik membantu Direktur dalam bidang Penunjang Rumah Sakit.
- c. Kepala Bidang Operasional membantu Direktur dalam bagian :
 - SDM yang meliputi ketenagakerjaan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia .
 - Keuangan dan Akutansi meliputi keuangan, akutansi dan pajak rumah sakit.
 - Umum meliputi : Saranan dan Prasarana Rumah Sakit, SIMRS, Rumah Tnagga, Humas dan Pemasaran, Manajemen Kontrak, dan Pengaduan Pelayanan serta hubungan dengan pihak eksternal.

3) Kepala Sub Bidang

Adalah pejabat yang membatu Kepala Bidang Pelayanan Medik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing-masing yaitu :

- a. Sub Bidang Keperawatan membantu Kepala Bidang Pelayanan Medik dalam bidang Keperawatan.

4) Kepala Sub Bagian

Adalah pejabat yang membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang masing – masing yaitu :

- b. Sub Bagian SDM membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas terkait ketenagakerjaan Rumah Sakit
- c. Sub Bagian Keuangan dan Akutansi membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas terkait Keuangan dan Akutansi.
- d. Sub Bagian Umum membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas terkait Sarana Prasaran Rumah Sakit, SIMRS, Security, Cleaning Service, Humas dan Pemasaran, Manajemen KONtrak dan Pengaduan Pelayanan

5) Kepala Instalasi dan Kepala Unit

Adalah suatu wadah struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dan memiliki fungsi tertentu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rumah sakit baik berfungsi pelayanan maupun pendukung operasional rumah sakit.

Berikut adalah daftar kepala instalasi dan kepala bagian :

- a. Kepala Instalasi Rawat Jalan
- b. Kepala Instalasi Rawat Inap
- c. Kepala *Intensive Care Unit*
- d. Kepala Instalasi Gawat Darurat
- e. Kepala Instalasi Kamar Operasi
- f. Kepala Instalasi Farmasi
- g. Kepala Instalasi Rekam Medis
- h. Kepala Unit Laboratorium

-
- i. Kepala Unit Radiologi
 - j. Kepala Unit Gizi
 - k. Kepala Unit Laundry
 - l. Kepala Unit Kamar Jenazah
 - m. Kepala Unit Fisioterapi
 - n. Kepala Bagian SDM
 - o. Kepala Bagian Keuangan dan Akutansi
 - p. Kepala Bagian Umum

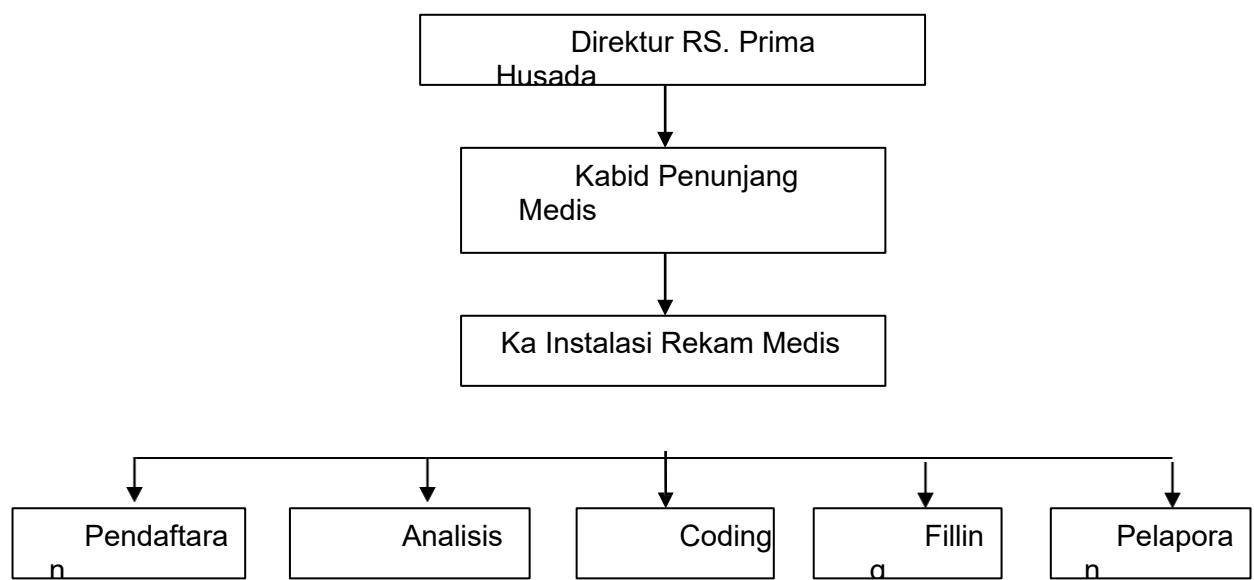
4.2.2 Unit Non Struktural

Adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli dan profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. Komite/ Panitia / Tim yang ada di Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut:

- a. Komite Medik
- b. Komite Keperawatan
- c. Komite PPI
- d. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
- e. Komite Etik
- f. Komite Farmasi & Terapi
- g. Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba
- h. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
- i. Tim Review Rekam Medis
- j. Tim TB DOTS
- k. Tim PONEK
- l. Tim Geriatri
- m. Tim HIV
- n. Tim PKRS
- o. Tim Casemix

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI REKAM MEDIS



5.1 Tanggung Jawab Instalasi Rekam Medis

Dalam pengelolaan organisasinya, secara struktural Bagian Rekam Medis berada langsung dibawah Kepala Bidang Penunjang Medis. Bagian Rekam Medis berfungsi sebagai salah satu “support division” yang memberikan kontribusi maksimal bagi semua “bussiness division”.

Secara fungsional, Bagian Rekam Medis melaporkan tanggung jawab pelayanannya kepada Ketua Instalasi yang ada, yakni :

- a. Ka Instalsi Rawat Jalan.
- b. Ka Instalasi Gawat Darurat.
- c. Ka Instalasi Rawat Inap.
- d. Ka Instalasi Operasi dan Intensive Care Unit.

5.2 Keanggotaan Instalasi Rekam Medis

Bagian Rekam Medis dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi Rekam Medis yang bertanggung jawab secara struktural ke Ka Bid Penunjang Medis dan bertanggung jawab secara fungsional kepada para KaUnit.

Bagian Rekam Medis RS. Prima Husada secara garis besar terdiri dari :

- a. Pendaftaran
- b. Filling / Penyimpanan Dokumen Rekam Medis

-
- c. Koding & Indeks Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan, Rawat Darurat dan Rawat Inap.
 - d. Asembling / perakitan Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan, Rawat Darurat dan Rawat Inap.
 - e. Pelaporan pelayanan internal dan eksternal.

BAB VI
URAIAN JABATAN

6.1 Uraian Tugas

No	Nama Jabatan	Persyaratan Jabatan	Uraian Tugas
1	Kepala Instalasi Rekam Medis	1. Pendidikan : - Lulusan D3 Rekam Medis - Memiliki STR dan SIK yang masih berlaku 2. Pengetahuan dan Keterampilan : - Pelatihan tentang manajemen rekam medis dan informasi kesehatan - Pelatihan Pelaporan RS - Menguasai pencatatan dan pelaporan dengan menggunakan program MS Excell 3. Pengalaman : Pengalaman kerja minimal 2 Tahun di bidang rekam medis	1. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan instalasi rekam medis dan informasi kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Membuat dan mengevaluasi sistem penerimaan pasien rawat jalan dan rawat inap. 3. Membuat dan mengevaluasi prosedur pencatatan rekam medis. 4. Merencanakan dan menetapkan formulir rekam medis. 5. Merencanakan dan mengevaluasi sistem dan prosedur penyimpanan dokumen rekam medis. 6. Merencanakan dan mengevaluasi sistem dan prosedur peminjaman dan pendistribuasian dokumen rekam medis. 7. Merencanakan dan membuat kriteria dalam rangka retensi dokumen rekam medis. 8. Memeriksa kebenaran kode penyakit dan kode tindakan medis. 9. Membuat dan menyajikan laporan kegiatan medis rumah sakit untuk kepentingan manajemen maupun pihak lain yang berkepentingan. 10. Membuat laporan dan analisa data morbiditas, mortalitas dan tindakan operasi. 11. Melaksanakan penilaian terhadap rekam medis in aktif untuk menilai dokumen rekam medis bernilai guna atau tidak. 12. Merencanakan kebutuhan sumber

			daya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit. 13. Membuat jadwal kerja, mengatur shift dinas, jadwal cuti dan libur. 14. Membuat permintaan kebutuhan sumber daya, atk, art, kebutuhan lain untuk pelaksanaan kegiatan instalasi rekam medis di rs. Prima husada.
--	--	--	---

No	Nama Jabatan	Persyaratan Jabatan	Uraian Tugas
----	-----------------	---------------------	--------------

			15. Membuat laporan intern dan ekstern rumah sakit secara berkala serta analisanya. 16. Membuat uraian pekerjaan bagi bawahan. 17. Mengawasi terhadap pelaksanaan kegiatan. 18. Memeriksa laporan kegiatan kunjungan rawat jalan, inap dan penunjang sebagai bahan pelaporan dan analisa. 19. Menyelesaikan masalah yang timbul di lingkungan instalasi rekam medis sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan. 20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung atau yang terkait dengan kegiatan Instalasi Rekam Medis
2	Pendaftaran	1. Pendidikan : - Lulusan D3 Rekam Medis atau Sarjana (S1) - Memiliki STR dan SIK yang masih berlaku 2. Pengetahuan dan Keterampilan : - Menguasai atau bisa program computer - Mampu berbahasa Inggris	1. Menerima pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap. 2. Melakukan identifikasi untuk memperoleh informasi kebutuhan pelayanan pasien rawat inap. 3. Mengidentifikasi pengisian formulir identitas sosial. 4. Entry data identitas sosial. 5. Meminta dokumen rekam medis pasien lama dari petugas penyimpanan. 6. Mengambil dokumen rekam medis. 7. Membuat laporan harian pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap.

		3. Pengalaman : Pengalaman kerja minimal 2 Tahun di bidang rekam medis terutama pendaftaran	
3	Assembling	1. Pendidikan : - Lulusan D3 Rekam Medis	1. Menerima dokumen rekam medis rawat inap dan rawat jalan dari penanggung jawab dokumen rekam medis.

No	Nama Jabatan	Persyaratan Jabatan	Uraian Tugas
----	-----------------	---------------------	--------------

		- Memiliki STR dan SIK yang masih berlaku 2. Pengetahuan dan Keterampilan : - Pelatihan tentang manajemen rekam medis - Menguasai pencatatan dan pelaporan dengan menggunakan program MS Excell 3. Pengalaman : Pengalaman kerja minimal 2 Tahun di bidang rekam medis	2. Memeriksa kelengkapan isi dokumen rekam medis 3. Menyusun dokumen rekam medis sesuai urutan yang telah ditentukan 4. Melengkapi identitas pasien dan nomor rekam medis pada setiap lembar dokumen rekam medis. 5. Menulis nomor dan nama pasien pada dokumen rekam medis serta menempelkan stiker tahun kunjungan terakhir. 6. Memisahkan dokumen rekam medis yang belum lengkap isinya dan diserahkan kepada penanggung jawab dokumen rekam medis untuk dikirim kepada yang berhak / berkewajiban melengkapi isi dokumen rekam medis tersebut. 7. Menyusun dan menyiapkan dokumen rekam medis baru rawat jalan maupun rawat inap untuk petugas penfataran. 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk menyelesaikan, menangani bila terjadi penyimpangan / kasus yang terjadi dikegiatan assembling.
--	--	---	---

4	Coding	1. Pendidikan : - Lulusan D3 Rekam Medis - Memiliki STR dan SIK yang masih berlaku 2. Pengetahuan dan Keterampilan : - Pelatihan tentang manajemen rekam medis - Menguasai pencatatan dan pelaporan dengan menggunakan program MS Excell	1. Mengkode diagnosa setiap dokumen rekam medis pasien yang berobat 2. Mengentry kode penyakit. 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk menyelesaikan, menangani bila terjadi penyimpangan / kasus yang terjadi dikegiatan kode penyakit pasien rawat jalan dan rawat inap.
---	--------	--	---

No	Nama Jabatan	Persyaratan Jabatan	Uraian Tugas
		- Menguasai ICD 10 - Menguasai ICD 9 CM 3. Pengalaman : Pengalaman kerja minimal 2 Tahun di bidang rekam medis	

5	Filling	1. Pendidikan : - Lulusan D3 Rekam Medis - Memiliki STR dan SIK yang masih berlaku 2. Pengetahuan dan Keterampilan : Pelatihan tentang manajemen rekam medis 3. Pengalaman : Pengalaman kerja minimal 2 Tahun di bidang rekam medis	1. Koordinasi permintaan dan pendistribusian dokumen rekam medis - Menerima permintaan dokumen rekam medis dari pendaftaran. - Menyiapkan <i>tracer</i> untuk dokumen rekam medis yang keluar. - Mengeluarkan dokumen rekam medis sesuai dengan nomor dokumen rekam medis yang diminta, dengan menempatkan <i>tracer</i> pada posisi rekam medis yang keluar. - Mencatat dokumen rekam medis yang akan dikirim ke poliklinik atau ruang perawatan dalam buku ekspedisi. - Memberikan dokumen rekam medis pasien yang diambil dari ruang penyimpanan ke pendaftaran untuk disiapkan dokumennya oleh petugas pendaftaran sebelum diantar ke ruang pemeriksaan. - Melaksanakan serah terima dokumen rekam medis dengan petugas pendaftaran.
6	Pelaporan	1. Pendidikan : - Lulusan D3 Rekam Medis - Memiliki STR dan SIK yang masih berlaku 2. Pengetahuan dan Keterampilan :	1. Melaksanakan kegiatan statistik dan pelaporan yang meliputi: - Mencetak sensus harian rawat jalan dan rawat inap. - Mengontrol kebenaran sensus harian sesuai jumlah pasien yang sebenarnya. - Merekap sensus harian rawat jalan berdasarkan spesialisasi dan dokter prakteknya. - Merekap sensus harian rawat inap masuk dan keluar

No	Nama Jabatan	Persyaratan Jabatan	Uraian Tugas
		- Pelatihan tentang manajemen rekam medis - Menguasai ICD 10 - Menguasai ICD 9 CM - Menguasai pencatatan dan pelaporan dengan menggunakan program MS Excell 3. Pengalaman : Pengalaman kerja minimal 2 Tahun di bidang rekam medis	berdasarkan kelas, spesialisasi dan dokter yang merawat. - Meminta data kunjungan dari unit lain terkait dengan laporan kegiatan rumah sakit. - Membuat laporan kunjungan pasien rawat jalan, rawat inap dan penunjang. - Laporan morbiditas, mortalitas dan trend penyakit. - Membuat laporan ekstern ke Departemen Kesehatan dan jajarannya.

6.2 Tanggung Jawab

No	Nama Jabatan	Tanggung Jawab
1	Kepala Instalasi Rekam Medis	1. Ketepatan dan kesesuaian rencana dan tata kerja di Instalasi Rekam Medis. 2. Ketepatan dan kebenaran pelaksanaan kegiatan: 3. Admission Dan Registrasi 4. Assembling dan indeks kode penyakit. 5. Statistik dan pelaporan rumah sakit. 6. Penyimpanan dan pendistribusian dokumen rekam medis yang sesuai dengan SPO 7. Ketepatan dan kesesuaian rencana kebutuhan sumber daya dengan realisasi. 8. Kebenaran dan ketepatan laporan kepada manajemen.

2	Pendaftaran	1. Bertanggung jawab atas kebenaran data identitas sosial yang di <i>entry</i> . 2. Bertanggung jawab atas informasi yang diberikan. 3. Bertanggung jawab atas pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap. 4. Bertanggung jawab atas perangkat kerja
3	Assembling	1. Bertanggung Jawab pada Kepala Instalasi RM 2. Kelengkapan dan kerapian isi dokumen RM
4	Coding	1. Kebenaran indeks kode penyakit 2. Bertanggung Jawab pada Kepala Instalasi RM
5	Filling	1. Ketepatan penyimpanan DRM di ruang filling 2. Ketepatan pendistribusian DRM ke ruang poli 3. Bertanggung jawab pada Kepala Instalasi Rekam Medis

No	Nama Jabatan	Tanggung Jawab
6	Pelaporan	1. Bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan penggunaan sensus harian. 2. Bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan laporan kunjungan pasien rawat jalan, inap dan penunjang, laporan morbiditas, mortalitas, dan penyakit menular, efisiensi pelayanan rawat inap, BOR, LOS. 3. Bertanggung jawab atas terisinya form asuransi, perusahaan rekanan, visum et repertum dan pengisian form untuk pihak ketiga yang berwenang. 4. Kebenaran laporan realisasi terhadap perencanaan / target yang ditetapkan.

6.3 Wewenang

No	Nama Jabatan	Wewenang
1	Kepala Instalasi Rekam Medis	1. Menilai, menegur dan memotivasi bawahan di Instalasi Rekam Medis. 2. Mengatur rencana kegiatan penyelenggaraan Instalasi Rekam Medis. 3. Meminta arahan dari atasan. 4. Meminta masukan dari bawahan dan unit kerja lain yang terkait.

		5. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan
2	Pendaftaran	1. Menghubungi dokter yang akan praktek untuk mengetahui kepastian kedatangannya. 2. Menghubungi pasien yang akan berobat untuk memastikan kedatangan pasien. 3. Memberikan masukan kepada atasan langsung
3	Assembling	1. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan. 2. Mengusulkan perbaikan perangkat kerja
4	Coding	1. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan 2. Mengusulkan perbaikan perangkat kerja
5	Filling	1. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan 2. Mengusulkan perbaikan perangkat kerja
6	Pelaporan	1. Mengatur rencana kegiatan statistik dan pelaporan 2. Meminta arahan dari atasan. 3. Mengeluarkan form asuransi, perusahaan rekanan, visum et repetum dan form dari pihak ketiga yang berwenang. 4. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan

6.4 Tugas Klinik

Tugas klinis yang dimaksud adalah seseorang yang bekerja di bidang manajemen mempunyai uraian tugas jabatan dan uraian tugas fungsional dan dilengkapi oleh SPK dan RKK

NO	D3	D4	S1	S2
1	Melaksanakan kegiatan pelayanan pasien dalam		-	Mengembangkan desain rekam medis elektronik sesuai kebutuhan sistem

NO	D3	D4	S1	S2
----	----	----	----	----

	manajemen dasar rekam medis dan informasi kesehatan			pelayanan dan pelaporan dengan menggunakan biostatistik;
2	Melaksanakan evaluasi isi rekam medis	Merancang sistem evaluasi isi rekam medis manual dan elektronik;	-	Mengembangkan desain yang spesifik sesuai kebutuhan pengembangan modul penelitian bersama dengan kelompok profesi lain;
3	Melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai terminologi medis yang benar;	Mengevaluasi sistem klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis dalam pembiayaan kesehatan	Mengevaluasi sistem klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis;	Mengembangkan kemampuan analisa <i>trend</i> penyakit dan mendistribusikan sesuai dengan otorisasi akses dan keamanan data;
4	Melaksanakan indeks dengan cara mengumpulkan data penyakit, kematian, tindakan dan dokter yang dikelompokkan pada indeks;	Memvalidasi indeks dengan cara menilai kumpulan data penyakit, kematian, tindakan dan dokter yang dikelompokkan pada indeks	Memvalidasi indeks dengan cara menilai kumpulan data penyakit, kematian, tindakan dan dokter yang dikelompokkan pada indeks	Mengembangkan kerja sama dengan tim epidemiologi dalam mendesain rancangan survei penyakit serta dalam demografi kependudukan;

5	Melaksanakan sistem pelaporan dalam bentuk informasi kegiatan pelayanan kesehatan;		-	Mengembangkan sistem informasi kesehatan masyarakat berbasis <i>website/</i> situs; dan
6	Merancang struktur isi dan standar data kesehatan, untuk pengelolaan	Merancang struktur isi dan standar data kesehatan, untuk pengembangan	Merancang dan mengembangkan struktur isi dan standar data kesehatan, untuk pengembangan informasi kesehatan	Mengembangkan sistem evaluasi pelayanan rekam medis elektronik yang dipublikasikan.

NO	D3	D4	S1	S2
	informasi kesehatan;	n informasi kesehatan		
7	Melaksanakan evaluasi kelengkapan isi diagnosis dan tindakan sebagai ketepatan pengkodean;	Memvalidasi kelengkapan diagnosis dan tindakan medis sebagai ketepatan pengkodean	Memvalidasi kelengkapan diagnosis dan tindakan medis sebagai ketepatan pengkodean	
8	Melaksanakan pengumpulan, validasi dan verifikasi data sesuai ilmu statistik rumah sakit;	Melaporkan hasil monitoring kinerja mutu pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan	Melakukan analisis data menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi	

		dan teknologi		
9	Melakukan pencatatan dan pelaporan data surveilans;	Memvalidasi kumpulan dan verifikasi data sesuai dengan jenis formulir survei	Memvalidasi kumpulan dan verifikasi data sesuai dengan jenis formulir survei	
10	Mengelola kelompok kerja dan manajemen unit kerja dan menjalankan organisasi penyelenggara dan pemberi pelayanan kesehatan;	Menganalisa dan mengevaluasi pengelolaan manajemen unit kerja serta menjalankan organisasi fasilitas pelayanan kesehatan	Menganalisa kegiatan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan;	
11	Mensosialisasi kan setiap program pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan;		Memberikan kontribusi pada kegiatan riset bidang pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan	
12	Melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan kode etik profesi; dan	Melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan kode etik profesi	Melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan kode etik profesi	

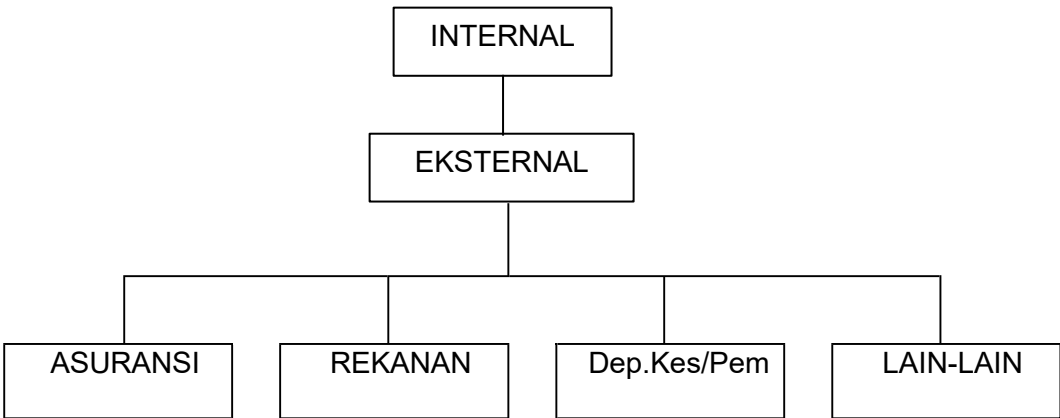
NO	D3	D4	S1	S2
13	Melakukan pengembangan diri terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi		Melakukan pengawasan pengelolaan informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip sistem rekam medis dan informasi kesehatan/Manajemen Informasi Kesehatan	
14		Menyelesaikan masalah secara prosedural baik manual/elektronik; dan	Membuat identifikasi permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi	
15			Merancang dan mengembangkan sistem jaringan rekam medis manual dan elektronik;	
16			Membuat rancangan alternatif solusi pengelolaan informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip	
17			Menciptakan rancangan baru (inovasi) alternatif solusi pengelolaan informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip	

18			Melakukan komunikasi kemitraan peneliti di bidang manajemen informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip sistem rekam medis dan informasi kesehatan/Manajemen Informasi Kesehatan	
----	--	--	---	--

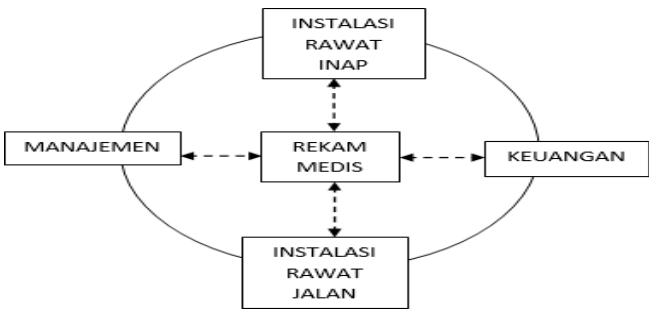
BAB VII

TATA HUBUNGAN KERJA

7.1 Skema Hubungan Kerja
Hubungan Eksternal



Hubungan Internal



Hubungan tata kerja di Instalasi Rekam Medis bersifat garis komunikasi, koordinasi dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan. Dilakukan melalui pertemuan dan atau surat dinas.

7.2 Hubungan Eksternal

- a. Instalasi Rekam Medis merupakan penyedia informasi kepada pihak ketiga yaitu Asuransi, Rekanan dan pihak lain. Misal : Memberikan pelayanan pendaftaran pasien asuransi seoptimal mungkin yang dituangkan ditegaskan kedalam sebuah SPO
- b. Instalasi Rekam Medis juga berkewajiban memberikan laporan kepada Departemen Kesehatan Pemerintah.
Misal : Mengirimkan laporan RL ke DINKES kabupaten maupun Propinsi

7.3 Hubungan Internal

- a. Instalasi rekam medis menyediakan data-data sebagai bahan komunikasi, koordinasi dan informasi yang dibutuhkan IRJA, IRNA, Keuangan dan Manajemen dalam mengambil keputusan. Misal: Dengan adanya SOP yang berkenaan dengan Dokumen

Rekam Medis dalam pelayanan yang berkaitan dengan IRJA, IRNA maupun IRD.

- b. Antara pasien dan dokter rekam medis berfungsi sebagai mediator dalam penyediaan rekam medis. Misal: SPO Permintaan pengisian Resume dokter bagi setiap pasien pengguna asuransi.

BAB VIII

POLA KETENAGAAN

8.1 Pola Ketenagaan

1) Penyusunan Pola Ketenagaan Sebagai Dasar Penempatan Staf

Dalam upaya mempersiapkan tenaga rekam medis yang handal, perlu kiranya melakukan kegiatan menyediakan, mempertahankan sumber daya manusia yang tepat bagi organisasi.

Atas dasar tersebut perlu adanya perencanaan SDM, yaitu proses mengantisipasi dan menyiapkan perputaran orang ke dalam, di dalam dan ke luar organisasi. Tujuannya adalah mendayagunakan sumber-sumber tersebut seefektif mungkin sehingga pada waktu yang tepat dapat disediakan sejumlah orang yang sesuai dengan persyaratan jabatan.

Perencanaan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan oganisasi dalam mencapai sasarannya melalui strategi pengembangan kontribusi.

Tabel 1. Pola Kebutuhan Tenaga Rekam Medis Berdasarkan Analisa Beban Kerja

NO	TUGAS POKOK	URAIAN TUGAS	RERATA VOLUM E KERJA SHIFT	WAKTU YANG DIBUTUHKAN	
				MENIT	JUMLAH
1	Pagi (06.30-14.00 WIB) dan Siang (14.00- 21.00 WIB)	Input Hasil pemeriksaan DB, HIV, HEPA di web	10	7	70
		Review ERM Open Disclosure	30	15	450
		Upload dokumen form edukasi di SIMRS	40	3	120
		menyiapkan orderan form untuk unit (ICU, HCU, PERINA,MTS)	20	10	200
		merakit bandelan form operasi	50	3	150
		validasi review E-RM IRJA pasien non BPJS	50	5	250
		Cek setoran DRM dan ERM rawat inap dari unit irna pasien BPJS	45	3	135
		Cek setoran DRM dan ERM rawat inap dari unit irna pasien UMUM	5	3	15

2	Analisa / review DRM dan ERM pasien umum dan bpjs	45	5	225
	follow up dokumen rekam medis ke unit irna dan semua PPA	20	2	40
	Pencarian dokumen rekam medis untuk keperluan klaim	2	5	10
	pencarian dokumen rekam medis untuk keperluan klaim RIP	2	10	20
	pencocokan closing dokumen rekam medis yang sudah setor ke RM di sistem SIMRS	45	10	450
	Pemilahan dokumen inaktif rawat jalan dan rawat inap	300	10	3000
	scan dokumen inaktif	300	10	3000
	Input hasil scan dokumen inaktif di SIMRS	300	3	900
	Total	1264		
	Jam Kerja	420		
	Total kebutuhan staf dalam satu shift	3,00952381		

Rumah sakit prima husada mengikuti perhitungan beban kerja sebanyak 9 orang, apabila di kemudian hari terdapat penambahan beban kerja meliputi penambahan volume pasien, peralihan metode pemeriksaan dari otomatis menjadi manual maka akan dilakukan evaluasi perhitungan pola ketenagaan ulang

2) Penempatan dan Penempatan Kembali Staf

Perencanaan kebutuhan yang tepat dengan jumlah yang mencukupi adalah hal yang sangat penting bagi asuhan pasien termasuk keterlibatan rumah sakit dalam semua kegiatan pendidikan dan riset. Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi. Sebagai contoh, seorang perawat yang memiliki kompetensi hemodialisis tidak dirotasi ke rawat jalan lain.

Pimpinan unit layanan membuat rencana pola ketenagaan dengan menggunakan proses yang sudah diakui untuk menentukan jenjang kepegawaian. Perencanaan kepegawaian meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penempatan kembali dari satu unit layanan ke lain unit layanan karena alasan kompetensi, kebutuhan pasien, atau kekurangan staf;
 - Staf yang mempunyai kompetensi tambahan seperti pelatihan Instrumen, pelatihan Kegawatdaruratan Perinatologi, Pelatihan ICU dasar, Pelatihan Anestesi tidak dapat dirotasi ke unit lain dikarenakan terdapat unit prioritas yang khusus membutuhkan kompetensi tambahan tersebut. Misalnya Staf yang memiliki pelatihan Instrumen, ditempatkan di Instalasi Kamar operasi, sebaliknya staf yang mempunyai kompetensi ICU dasar ditempatkan di *Instalasi Care Unit* (ICU)
 - Penempatan staf dapat dilakukan apabila dalam unit tersebut terdapat kebutuhan mendesak sedangkan staf yang dibutuhkan belum tersedia, maka staf tersebut di rotasi sementara untuk menjaga stabilitas pelayanan dengan tetap memperhatikan kualifikasi dan Rincian Kewenangan Klinis yang sesuai.
- b. Mempertimbangkan keinginan staf untuk ditempatkan kembali karena alasan nilai-nilai, kepercayaan, dan agama;
Mengkaji keinginan staf untuk ditempatkan pada unit yang sesuai berdasarkan hasil psikotest, menggali nilai kepribadian staf apakah lebih berpotensi pada unit pelayanan atau manajemen, atau bahkan marketing yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
- c. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi, surat penugasan klinis dan rincian

kewenangan klinis yang telah disetujui Direktur RS Prima Husada dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Setiap staf mempunyai tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas dan fungsinya. Dalam hal ini kompetensi dan kewenangan menjadi dasar dalam menentukan penempatan, uraian pekerjaan, dan kriteria untuk evaluasi kinerja staf.

Uraian tugas juga diperlukan untuk tenaga kesehatan profesional dengan ketentuan sebagai berikut :

- Staf yang bekerja terutama di bidang manajemen dan fungsional. Contoh, dokter spesialis bedah merangkap sebagai Kepala Instalasi Kamar Operasi dan sebagai dokter bedah harus mempunyai STR, SIP, SPK, RKK dan

sebagai kepala instalasi kamar operasi mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;

- seseorang dalam program pendidikan dan bekerja di bawah supervisi maka program pendidikan menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan sesuai dengan tingkat pendidikannya; bagi mereka yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan melakukan praktik mandiri harus dilakukan proses untuk identifikasi dan memberikan wewenang melaksanakan praktik dengan dasar latar belakang pendidikan, kompetensi, pelatihan, dan pengalaman. Persyaratan standar ini berlaku untuk semua jenis staf yang harus ada uraian tugasnya. (contoh, penugasan penuh waktu, paruh waktu, dipekerjakan, sukarela, sementara)

8.2 Evaluasi dan Pemutakhiran Staf

- 1) Pemutakhiran dan evaluasi staf dilakukan setiap satu tahun sekali dan dilaporkan tiap bulan di laporan bulanan
- 2) Dihadiri oleh Direktur, Kepala Bidang, Kepala Unit, SDM
- 3) Setiap ada staf yang melakukan pengunduran diri
- 4) Setiap penambahan jenis pelayanan, jumlah pasien dan jumlah alat yang mempengaruhi perhitungan awal pola ketenagaan

8.3 Jumlah Staf Unit

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH SDM		KET
		STANDART	KONDISI SAAT INI	
1	Kepala Ruang Rekam medis	1 orang	1 orang	Sesuai
2	Pendaftaran / Administrasi	14 orang	14 orang	Sesuai
3	Analisa / review rekam medis	4 orang	4 orang	-
4	Penyimpanan dan distribusi DRM	15 orang	2 orang	-
5	Pelaporan Rumah Sakit	1 orang	-	-
6	Coding	2 orang	-	-
7	Retensi	1 orang	-	-

BAB IX

KEGIATAN ORIENTASI

Pengertian Orientasi adalah usaha membantu para pekerja agar mengenali secara baik dan mampu beradaptasi dengan suatu situasi atau dengan lingkungan / iklim bisnis suatu organisasi / perusahaan.

Orientasi harus mampu membantu para pekerja baru untuk memahami dan bersedia melaksanakan perilaku sosial yang mewarnai kehidupan organisasi / perusahaan sehari-hari.

Orientasi juga harus mampu membantu para pekerja baru untuk mengetahui dan memahami berbagai aspek teknis pekerjaan/ jabatannya, agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif, efisien dan produktif.

HARI	MATERI	METODE	PENANGGUNG JAWAB
INSTALASI REKAM MEDIS			
I (Hari I)	Orientasi hari pertama : ➤ Penjelasan status pegawai dan tata tertib di bagian Rekam Medis ➤ Penjelasan tentang Pelaporan Pelaporan yang ada di bagian Rekam Medis ➤ Penjelasan Tentang SPO bagian Rekam Medis.	Penjelasan singkat Teori dan Praktek	Kepala Bagian Rekam Medis Kepala Unit Kerja Penanggung Jawab Ruang Filling
Hari 2-3	Orientasi hari II s.d. III Meliputi : ➤ Penjelasan tentang sistim Penyimpan ➤ Penjelasan Tentang Sistim Penjajaran ➤ Penjelasan Tentang Rekam Medis Aktif dan Inaktif. ➤ Penjelasan Tentang Penggunaan Out Guide,Tracer. ➤ Praktek Mengambil Dokumen Rekam Medis di Ruang Penyimpanan.		Kepala Bagian Rekam Medis Penanggung Jawab sensus harian

HARI	MATERI	METODE	PENANGGUNG JAWAB
Hari ke 4-5	Penjelasan Tentang Sensus Harian IRNA Penjelasan Tentang Hari Penjelasan Tentang Sensus Harian IRNA ➤ Penjelasan Tentang Hari Perawatan dan Lama dirawat ➤ Penjelasan Tentang Bed Occupation Ratio ➤ Praktek Mengambil Sensus di Ruangan ➤ Praktek Pengurutan Sensus Per Jenis Pelayanan Praktek Menginput Data Sensus ke Komputer Dengan Menggunakan Program Mic Exel		
Hari ke 6-7	Orientasi Hari Ke-6 Sampai Hari Ke-7 Meliputi ➤ Pengenalan Tentang Buku Exspedisi Penyerahan Dokumen Rekam Medis Dari Rawat Inap. ➤ Penjelasan Tentang Pengurutan Dokumen Rekam Medis/Assembling ➤ Penjelasan Tentang Evaluasi Kelengkapan DRM ➤ Penjelasan Tentang Informed Conccent	Teori dan Praktek	Kepala Bagian Rekam Medis Petugas Assembling dan Evaluasi

	➤ Penjelasan Tentang Laporan Kelengkapan DRM yang dilaporkan ke Ka.Instalasi.		
PENDAFTARAN			

HARI	MATERI	METODE	PENANGGUNG JAWAB
Hari ke 1-4	➤ Penjelasan Tentang Lembar Lembar Yang Digunakan Dalam Proses Admission. Sebelum Dokumen di distribusikan ke Poliklinik ➤ Praktek Admission Penjelasan dan Praktek Tentang Penggunaan komputer	Teori dan Praktek	Kepala Bagian Rekam Medik
Hari ke 5	➤ Penjelasan Tentang Proses Pendaftaran Pasien Umum, BPJS dan Asuransi. ➤ Praktek Mendaftar Pasien Umum ➤ Praktek Mendaftar Pasien BPJS ➤ Penjelasan Tentang SPM	Teori dan Praktek	Koordinator Pendaftaran

	Pendaftaran Pasien Rawat Jalan		
Hari ke 6-7	➤ Penjelasan Tentang Pendaftaran Pasien Rawat Inap dan Persyaratannya jika pasien BPJS ➤ Praktek Mendaftar Pasien Rawat Inap ➤ Praktek menginput data Pasien Rawat Inap Melalui Komputer	Praktek dan Teori Post Test dan Interview	Kepala Bagian Rekam Medis Koordinator Pendaftaran

BAB X
PERTEMUAN/RAPAT

10.1 Rapat Rutin Bulanan

1. Rapat Rutin koordinasi dibawah Kepala Instalasi Rekam Medis diselenggarakan pada :

Waktu : Setiap Akhir Bulan

Jam : 13:00 s/d selesai

Tempat : Ruang Instalasi Rekam Medis

Peserta : Seluruh anggota rekam medis

Materi :

- Evaluasi kinerja dan koordinasi .
- Pembahasan permasalahan / studi kasus.
- Rekomendasi dan usulan untuk peningkatan kinerja dan koordinasi seputar rawat jalan.
- Sosialisasi kebijakan baru (jika ada).

2. Rapat Kerja antar unit bersama Direksi diselenggarakan pada :

Waktu : Setiap hari Jumat

Jam : 13:00 s/d selesai

Tempat : Ruang Hall DPM Lantai 2d

Peserta : Seluruh Kepala Unit / Kepala Bagian, Manajer dan Direktur.

Materi :

- Evaluasi kegiatan pelayanan dan pencapaian pelayanan tiap unit.
- Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tiap unit.
- Pembahasan permasalahan / studi kasus.
- Rekomendasi dan usulan untuk peningkatan kinerja dan koordinasi.
- Sosialisasi kebijakan baru.

10.2 Rapat Insidentil

Rapat Insidentil diselenggarakan pada :

Waktu : Sewaktu-waktu bila ada masalah atau sesuatu hal yang perlu dibahas dan diselesaikan segera.

Jam : Sesuai undangan

Tempat : Sesuai undangan

Peserta : Seluruh petugas rekam medis.

Materi : Sesuai dengan masalah yang perlu dibahas

BAB XI

PELAPORAN

11.1 Laporan Harian :

- Kirim satu sehat
- Laporan HIV
- Pelaporan tersangka DHF
- Laporan Hepatitis
- Laporan update SIRS ONLINE

11.2 Laporan Bulanan :

- RL 3.1 Indikator Pelayanan
- RL 3.2 Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Rawat Inap
- RL 3.3 Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Rawat Darurat
- RL 3.4 Rekapitulasi Pengunjung
- RL 3.5 Rekapitulasi Kunjungan
- RL 3.6 Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kebidanan
- RL 3.7 Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Neonatal, Bayi, dan Balita
- RL 3.8 Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Laboratorium
- RL 3.9 Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Radiologi
- RL 3.10 Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Rujukan
- RL 3.12 Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Pembedahan
- RL 3.14 Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Khusus
- RL 4.1 Kompilasi Penyakit/Morbiditas Pasien Rawat Inap
- RL 4.2 10 Besar Penyakit Rawat Inap
- RL 4.3 10 Besar Kematian Penyakit Rawat Inap
- RL 5.1 Kompilasi Morbiditas Pasien Rawat Jalan
- RL 5.2 10 Besar Kasus Baru Penyakit Rawat Jalan
- RL 5.3 10 Besar Kunjungan Penyakit Rawat Jalan
- Laporan kelengkapan analisa DRM
- Laporan bulanan internal RS
- Laporan update SIRS ONLINE

11.3 Laporan Tahunan :

- RL 3.11 Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Gigi dan Mulut
- RL 3.13 Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Medik
- RL 3.15 Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa
- RL 3.16 Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana
- RL 3.17 Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Farmasi RS-Pengadaan Obat
- RL 3.18 Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Farmasi RS-Resep
- RL 3.19 Rekapitulasi Cara Bayar

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 30 Januari 2026

PLT Direktur RS Prima Husada,



dr. Resti Lestantini, M. Kes

